



Nuansa
Fajar
Cemerlang

HUBUNGAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN DI KALANGAN PERAWAT DI INDONESIA STUDI LINTAS BUDAYA

Ernawati Umar
Tuti Sulastri



HUBUNGAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN DI KALANGAN PERAWAT DI INDONESIA STUDI LINTAS BUDAYA

Penulis:

Dr. Ns. Ernawati Umar, S.Kep., N.M.

Ns. Tuti Sulastrri, S.Kep., M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Hubungan Manajemen Pemberdayaan dan Budaya Keselamatan Pasien Di Kalangan Perawat Di Indonesia Studi Lintas Budaya

Penulis: Dr. Ns. Ernawati Umar,S.Kep., N.M.
Ns. Tuti Sulastri, S.Kep., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7139-16-0

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahman dan rahimnya telah memberikan kesehatan, kelancaran, dan kesempatan membuat buku, yang berjudul **"Hubungan Manajemen Pemberdayaan dan Budaya Keselamatan Pasien di Kalangan Perawat di Indonesia"**, dapat terselesaikan. Buku ini dibuat atas kepedulian kami terhadap pentingnya peran Manajemen Keperawatan dalam Pemberdayaan dan Budaya keselamatan pasien untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan

Keselamatan pasien merupakan prioritas dalam melakukan tugas sebagai seorang perawat oleh karenanya . Budaya keselamatan memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang aman bagi pasien. Masih ditemui masalah terkait budaya keselamatan pasien dan sikap pelaporan insiden keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien dapat berhubungan dengan sikap perawat dalam pelaporan insiden. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan budaya keselamatan pasien dengan sikap perawat dalam pelaporan insiden keselamatan pasien.

Buku ini kami susun sesuai dengan kaidah kaidah budaya keselayan pasien terkait manajemen kebijakan yang diterapkan di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya dengan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan beberapa aspek para manajemen bidang kesehatan, antara lain sumber daya manusianya, kepala bidang keperawatan, kepala seksi pelayanan, kepala ruangan, ketua tim, perawat asosiet, manajemen keselamatan pasien, dan lingkungan yang mengutamakan keselamatan pasien Selain itu, kami berupaya untuk menyajikan informasi yang mudah dipahami, berbasis bukti, dan aplikatif sehingga dapat menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam proses penulisan buku ini. Terima kasih kepada sejawat perawat, para, pakar kesehatan, dan keluarga yang memberikan inspirasi, masukan, serta motivasi. Kami juga berterima kasih kepada penerbit yang telah memberikan kepercayaan untuk menerbitkan karya ini.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat nyata dalam upaya pencegahan kejadian yang tidak diinginkan, dan meningkatkan keselamatan pasien serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB 2 PEMBERDAYAAN DAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN.....	5
--	----------

A. Pengertian Asuhan	5
B. Penerapan Pemberdayaan	6
C. Budaya Keselamatan Pasien	7
D. Kejadian Tidak Diharapkan.....	9

BAB 3 INDIKATOR PASIEN SAFETY	13
--	-----------

A. Langkah Menuju Keselamatan.....	13
B. Tujuh Langkah Keselamatan Pasien.....	19
C. Sasaran Keselamatan Pasien.....	25

BAB 4 PERAN PERAWAT DALAM KESELAMATAN PASIEN	35
---	-----------

A. Peran Perawat Dalam Mewujudkan Penerapan Patient Safety Di Rumah Sakit.....	41
B. Faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam pelaksanaan <i>Patient Safety</i> dan perlindungan hak pasien	47

BAB 5 ASUHAN KEPERAWATAN DALAM KESELAMATAN

PASIEN.....53

- A. Keselamatan Pasien 53
- B. Keselamatan Pasien dalam Asuhan Keperawatan 58
- C. Tujuan Proses Keperawatan..... 59
- D. Penerapan Standar Asuhan Keperawatan Terhadap
Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit 61

DAFTAR PUSTAKA.....71

GLOSARIUM75

PROFIL PENULIS77

BAB 1

PENDAHULUAN

Sebuah realisasi yang menentukan pada tahun 1990 adalah bahwa, terlepas dari semua kekuatan obat modern yang diketahui untuk menyembuhkan dan memperbaiki penyakit, rumah sakit bukanlah tempat yang aman untuk penyembuhan. Sebaliknya, rumah sakit adalah tempat yang penuh dengan risiko yang membahayakan pasien. Salah satu respon penting terhadap realisasi ini adalah meningkatnya minat terhadap keselamatan pasien. Semakin jelas bahwa keselamatan pasien telah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri, lengkap dengan pengetahuan dan keahlian terpadu, dan memiliki potensi untuk merevolusi perawatan kesehatan, mungkin sama radikalnya dengan biologi molekuler yang secara dramatis meningkatkan kemampuan terapeutik dalam pengobatan.

Budaya keselamatan memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang aman bagi pasien. Masih ditemui masalah terkait budaya keselamatan pasien dan sikap pelaporan insiden keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien dapat berhubungan dengan sikap perawat dalam pelaporan insiden. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan budaya keselamatan pasien dengan sikap perawat dalam pelaporan insiden keselamatan pasien. Penelitian Cross Sectional menggunakan cluster sampling ini dilakukan dengan pengisian kuesioner yang melibatkan 400 perawat di tiga rumah sakit umum daerah di tiga kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penerapan budaya keselamatan pasien yang memadai akan menghasilkan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya dinilai dari kelengkapan teknologi, kecanggihan infrastruktur, dan tenaga kesehatan yang *system22e2al*, tetapi juga dari proses dan hasil pelayanan yang diberikan (Siregar, 2020)

Tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit merupakan panduan yang komprehensif untuk menuju keselamatan pasien, sehingga tujuh langkah tersebut secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit.

Keselamatan pasien/ klien adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi penilaian risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan pasien koma, pelaporan dan analisis *accident*, kemampuan belajar dari *accident* dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko (Dep Kes RI, 2006). Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan tanggung jawab dari tenaga kesehatan termaksud perawat dalam rangka mengurangi fenomena *medicalerror*.

Seorang pearawat bertindak sebagai salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai waktu kontak dengan pasien yang lebih lama dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya *medical error* pada pasien lebih tinggi dilakukan oleh perawat.

Perawat mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Patient safety di rumah sakit yaitu sebagai pemberi pelayanan keperawatan, perawat harus mematuhi semua standar pelayanan dan SOP yang telah dibuat dan ditetapkan oleh rumah sakit serta tidak luput pula dalam menerpkan prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan, memberikan pendidikan kepada pasien dan

keluarga tentang asuhan yang diberikan, menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian yang tidak diharapkan, melakukan pendokumentasian dengan benar dari semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga serta komunikasi efektif yang merupakan hal yang sangat berperan terhadap keberhasilan suatu pelayanan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya.

BAB 2

PEMBERDAYAAN DAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN

A. Pengertian Asuhan

Elemen penting dari layanan kesehatan berkualitas tinggi adalah keselamatan pasien. Sebagai penyedia layanan kesehatan, kita harus mengatasi beberapa kendala di bidang kesehatan, meskipun dengan pemantauan terus menerus, untuk menjamin keselamatan pasien dan pengobatan yang tepat. Ilmu pengetahuan terkait keselamatan pasien kini mendapat banyak perhatian, dan diharapkan perhatian ini akan tercermin dalam penerapan tindakan perbaikan berdasarkan identifikasi masalah (Indriyani Saputri, 2022).

Keselamatan pasien disuatu institusi layanan kesehatan seperti rumah sakit merupakan cermin dari kualitas pelayanan. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien dan dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisis dan menerapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Keselamatan pasien merupakan sebuah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut terdiri dari asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang

disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Insiden keselamatan pasien merupakan setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Budaya keselamatan suatu organisasi adalah hasil dari nilai-nilai individu dan kelompok, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku yang menentukan komitmen, dan gaya serta kemahiran, kesehatan dan keselamatan pengelolaan organisasi dengan budaya keselamatan positif ditandai oleh komunikasi yang dibangun atas dasar saling percaya, dengan berbagai persepsi tentang pentingnya keamanan, dan keyakinan akan kemanjuran tindakan pencegahan (AHRQ Hospital Survey on Patient Safety Culture: User's Guide, 2016).

B. Penerapan Pemberdayaan

Nilai, sikap, dan tindakan yang dimiliki orang-orang dalam suatu organisasi terhadap keselamatan yang mengutamakan dan mendorong peningkatan keselamatan pasien dikenal sebagai budaya keselamatan pasien. "Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien di Rumah Sakit" menyatakan bahwa langkah pertama dalam mencapai keselamatan pasien adalah dengan mengembangkan atau membangun budaya keselamatan pasien (Hamzah et al., 2019).

Penerapan budaya keselamatan pasien yang memadai akan menghasilkan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya dinilai dari kelengkapan teknologi, kecanggihan infrastruktur, dan tenaga kesehatan yang profesional, tetapi

juga dari proses dan hasil pelayanan yang diberikan (Siregar, 2020). Sejumlah aspek, termasuk persepsi, komunikasi, dan penerapan keselamatan kerja, serta pengetahuan, organisasi, motivasi, kompetensi, dan kepemimpinan, berdampak pada peran perawat dalam budaya keselamatan pasien. Kesalahan yang terjadi sering kali merupakan akibat dari kelalaian petugas layanan kesehatan, yang mungkin mencakup gangguan tugas, tertidur, atau kurangnya perhatian. Tekanan kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan petugas menjadi lelah, sehingga mengakibatkan kecerobohan.

C. Budaya Keselamatan Pasien

Upaya keselamatan pasien untuk mengurangi angka kejadian tidak diinginkan di rumah sakit, yaitu dengan menerapkan tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit (PMK No11, 2017). Antara lain yaitu: Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, Pimpin dan dukung staf, Integrasikan aktivitas pengelolaan risiko, Kembangkan sistem pelaporan, Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien, Belajar dan berbagi sebuah pengalaman tentang keselamatan pasien, Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Upaya menciptakan atau membangun budaya keselamatan (*safety culture*) merupakan langkah pertama dalam langkah- langkah mencapai keselamatan pasien, sebagaimana tercantum pula dalam langkah pertama dari konsep "Tujuh Langkah Menuju keselamatan pasien RS" (Yasmi & Thabrany, 2015).

Budaya keselamatan pasien didefinisikan sebagai produk dari nilai-nilai, sikap, persepsi, kompetensi dan pola perilaku individu dan kelompok, yang menentukan komitmen dan gaya serta kemahiran manajemen

keselamatan dan kesehatan organisasi. Budaya keselamatan pasien diterapkan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dalam mencegah error dan melaporkan jika terjadi insiden. (Rochmah, 2019). Organisasi dengan budaya keselamatan positif ditandai oleh komunikasi yang dibangun atas dasar saling percaya, dengan berbagai persepsi tentang pentingnya keamanan, dan keyakinan akan kemanjuran tindakan pencegahan (AHRQ *Hospital Survey on Patient Safety Culture: User's Guide*, 2016).

Permenkes RI No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, dikatakan Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, terdiri dari Kondisi Potensial Cedera (KPC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). Selain Insiden diatas, terdapat KTD yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien yang dikenal dengan kejadian sentinel. Kejadian tidak diharapkan (KTD)/*adverse event* yaitu insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit dasarnya atau kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalahan medis. Salah satu tujuan keselamatan pasien yaitu menurunkan KTD yang merupakan bagian dari insiden keselamatan pasien. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah Sasaran Keselamatan pasien yang bertujuan mendorong perbaikan

spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan dan menjelaskan bukti serta solusi dari konsensus berbasis bukti dan keahlian atas permasalahan yang ada. (Najihah, 2018).

Menurut Depkes RI (2008) dalam Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit, langkah pertama program keselamatan pasien di rumah sakit adalah membangun budaya keselamatan pasien atau menumbuhkan kesadaran pada seluruh karyawan akan pentingnya nilai keselamatan di rumah sakit. Peran perawat juga penting dalam mencegah dan menemukan kesalahan medis yang dapat menyebabkan kematian dan ancaman serius. Berdasarkan sebuah studi mengenai Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) akibat kesalahan medikasi yang dilaksanakan di beberapa rumah sakit di United States of America (USA) ditemukan fakta bahwa 34% kesalahan medikasi terjadi akibat kesalahan pemberian medikasi yang merupakan salah satu peran perawat dalam studi serupa yang dilaksanakan di dua rumah sakit tersier menunjukkan bahwa 38% Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) terjadi akibat kesalahan pemberian medikasi yang dilakukan oleh staff keperawatan (Bates et al., 1995, Pepper, 1995 dalam Page, 2004).

D. Kejadian Tidak Diharapkan

Sebagian besar kejadian tidak diinginkan terjadi pada kesalahan medis serta masalah dalam perawatan pasien (Aspend, 2017). Data di Amerika memperlihatkan bahwa 1.5 juta orang terluka setiap tahunnya dan rata-rata pasien yang di rawat inap mengalami satu kesalahan setiap harinya. Mengalami memperkirakan rata-rata 10% dari semua kunjungan rawat inap menimbulkan beberapa bentuk

bahaya yang tidak diinginkan, laporan dari negara-negara berkembang juga menunjukkan angka 77% pada kasus KTD (Aspend, 2017). *Institute of Medicine* (IOM) melaporkan angka KTD pada rumah sakit di Amerika Serikat yaitu 1.5 juta pasien terluka pertahun dari kesalahan

pengobatan, data 7000 diantaranya dilaporkan meninggal (Webair, H, et al., 2015). Temuan hasil penelitian di negara Arab 2,5% juta sampai 18 % Kejadian Tidak Diharapkan terjadi pada pasien, dari data tersebut 83% kejadian dapat dicegah dari kejadian tersebut memiliki efek samping resiko terhadap kematian pasien (Najjar, et al., 2013).

Di Indonesia, laporan insiden keselamatan pasien berdasarkan provinsi pada tahun 2014 dilaporkan provinsi DKI Jakarta menempati urutan tertinggi yaitu 37,9 % diantara delapan provinsi lainnya (Jawa Tengah 15,9 %, D.I Yogyakarta 13,8 %, Jawa Timur 11,7 %, Sumatera Selatan 6,9 %, Jawa Barat 2,8 %, Bali 1,4 %, Aceh 1,07 %, dan Sulawesi Selatan 0,7 %) (KKP-RS, 2014) Laporan Insiden Keselamatan Pasien di Indonesia berdasarkan propinsi menemukan bahwa dari 145 insiden yang dilaporkan 55 kasus (37,9%) terjadi di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan jenisnya dari 145 insiden yang dilaporkan didapatkan Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sebanyak 69 kasus (47,6%), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) sebanyak 67 kasus (46,2%), dan lain-lain sebanyak 9 kasus (6,2%). Walaupun data ini telah ada secara umum di Indonesia, kejadian atau catatan yang berhubungan dengan keselamatan pasien di rumah sakit belum dikembangkan secara menyeluruh oleh semua rumah sakit sehingga perhitungan kejadian yang berhubungan dengan keselamatan pasien masih sangat terbatas (Lumenta, 2008; Umaternate, Kumaat, & Mulyadi, 2015) dalam jurnal

(Simamora, 2019)

Angka Kematian Akibat KTD pada pasien rawat inap di seluruh Amerika berjumlah 44.000-98.000 orang pertahun. Dengan menggunakan estimasi yang lebih rendah, lebih banyak orang mati akibat kesalahan medis dalam setahun dibandingkan kecelakaan jalan raya, kanker payudara, atau AIDS. Laporan ini disusul dengan publikasi WHO pada tahun 2004 yang menemukan KTD dengan rentang 3,2-16,6% dari penelitian di berbagai negara (Depkes RI, 2008). Di Indonesia Laporan Insiden Keselamatan Pasien menemukan adanya pelaporan kasus KTD (14,41%) dan KNC (18,53%) yang disebabkan karena proses atau prosedur klinik (9,26 %), medikasi (9,26%), dan Pasien jatuh (5,15%). (KKPRS, 2011)

Tujuan Keselamatan pasien di rumah sakit yaitu (Depkes RI, 2011). 1) Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. 2). Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. 3) Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit. 4) Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan (KTD). Salah satu tujuan keselamatan pasien yaitu menurunnya KTD yang merupakan bagian dari insiden keselamatan pasien. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah Sasaran Keselamatan pasien yang bertujuan mendorong perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan dan menjelaskan bukti serta solusi dari konsensus berbasis bukti dan keahlian atas permasalahan yang ada. Penyusunan sasaran ini mengacu kepada *Nine Life-Saving Patient Safety Solutions* dari WHO Patient Safety (2007) yang digunakan juga oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit PERSI (KKPRS PERSI), dan dari *Joint Commission International* (JCI).

Ada 12 dimensi yang terkandung didalam budaya keselamatan pasien yakni: 1) Frekuensi pelaporan insiden. 2) Persepsi tentang keselamatan pasien secara menyeluruh. 3) Harapan dan tindakan manajer dalam meningkatkan keselamatan pasien. 4) Pembelajaran organisasi- perbaikan berkelanjutan. 5) Kerjasama tim dalam unit. 6) Komunikasi terbuka. 7) Umpan balik dan komunikasi tentang kesalahan. 8) Respon tidak menghukum terhadap kesalahan. 9) Staffing 10) Dukungan manajemen rumah sakit terhadap program keselamatan pasien. 11) Kerjasama tim antar unit. 12) Overan dan transisi (Sorra & Nieva, 2003).

BAB 3

INDIKATOR PASIEN SAFETY

A. Langkah Menuju Keselamatan.

Mengacu kepada standar keselamatan pasien, maka rumah sakit harus merancang proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Proses perancangan tersebut harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan “Tujuh Langkah Keselamatan Pasien Rumah Sakit”. Uraian Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Membangun Kesadaran Akan Nilai Keselamatan Pasien
Menciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil.

Langkah penerapan:

- a. Rumah Sakit:

Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menjabarkan apa yang harus dilakukan staf segera setelah terjadi insiden, bagaimana langkah-langkah pengumpulan fakta harus dilakukan dan dukungan apa yang harus diberikan kepada staf, pasien dan keluarga.

- 1) Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang

menjabarkan peran dan akuntabilitas individual bilamana ada insiden.

- 2) Tumbuhkan budaya pelaporan dan belajar dari insiden yang terjadi di rumah sakit.
- 3) Lakukan asesmen dengan menggunakan 14 sistem penilaian keselamatan pasien.

b. Bagi Unit/Tim:

- 1) Pastikan rekan sekerja anda merasa mampu untuk berbicara mengenai kepedulian mereka dan berani melaporkan bilamana ada insiden.
- 2) Demonstrasikan kepada tim anda ukuran-ukuran yang dipakai di rumah sakit anda untuk memastikan semua laporan dibuat secara terbuka dan terjadi proses pembelajaran serta pelaksanaan tindakan/solusi yang tepat.

2. Memimpin dan Mendukung Staf

Membangun komitmen dan focus yang kuat dan jelas tentang Keselamatan Pasien di rumah sakit. Langkah penerapan:

a. Untuk Rumah Sakit:

- 1) Pastikan ada anggota Direksi atau Pimpinan yang bertanggung jawab atas Keselamatan Pasien
- 2) Identifikasi di tiap bagian rumah sakit, orang-orang yang dapat diandalkan untuk menjadi "penggerak" dalam Gerakan
- 3) Keselamatan pasien prioritas dalam agenda rapat direksi/pimpinan maupun rapat manajemen rumah sakit
- 4) Masukkan keselamatan pasien dalam semua program Latihan staf rumah sakit anda dan pastikan pelatihan ini diikuti dan diukur efektifitasnya

- b. Untuk Unit/Tim
 - 1) Nominasikan penggerak dalam Tim anda sendiri untuk memimpin Gerakan keselamatan pasien
 - 2) Jelaskan kepada tim anda relevansi dan pentingnya serta manfaat bagi mereka dengan menjalankan gerakan Keselamatan Pasien
 - 3) Tumbuhkan sikap ksatria yang menghargai pelaporan insiden.
- 3. Mengintegrasikan Aktivitas Pengelolaan risiko
 Mengembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah.
 Langkah penerapan:
 - a. Untuk Rumah Sakit:
 - 1) Telah kembali struktur dan proses yang ada dalam manajemen risiko klinis dan nonklinis, serta pastikan hal tersebut mencakup dan terintegrasi dengan Keselamatan Pasien dan staf;
 - 2) Kembangkan System e-indikator kinerja bagi System pengelolaan risiko yang dapat dimonitor oleh direksi/pimpinan rumah sakit;
 - 3) Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari System pelaporan insiden dan asesmen risiko untuk dapat secara proaktif meningkatkan kepedulian terhadap pasien.
 - b. Untuk Unit/Tim:
 - 1) Bentuk forum-forum dalam rumah sakit untuk mendiskusikan isu –isu Keselamatan Pasien guna memberikan umpan balik kepada manajemen yang terkait;
 - 2) Pastikan ada penilaian risiko pada individu pasien dalam proses asesmen risiko rumah sakit;

- 3) Lakukan proses asesmen risiko secara teratur, untuk menentukan akseptabilitas setiap risiko, dan ambillah langkah-langkah yang tepat untuk memperkecil risiko tersebut;
 - 4) Pastikan penilaian risiko tersebut disampaikan sebagai masukan ke proses asesmen dan pencatatan risiko rumah sakit.
4. Mengembangkan sistem pelaporan
- Memastikan staf dapat melaporkan kejadian/insiden, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Langkah penerapan:
- a. Untuk Rumah Sakit lengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden kedalam maupun keluar yang harus dilaporkan ke Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit
 - b. Untuk Unit/Tim: Berikan semangat kepada rekan sekerja anda untuk secara aktif melaporkan setiap insiden yang terjadi dan insiden yang telah dicegah tetapi tetap terjadi juga, karena mengandung bahan pelajaran yang penting
 - 1) Pastikan
5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien
- Mengembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. Langkah penerapan :
- a. Untuk Rumah sakit
 - 1) Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang secara jelas menjabarkan cara-cara komunikasi terbuka selama proses asuhan tentang insiden dengan para pasien dan keluarganya.
 - 2) Pastikan pasien dan keluarga mereka mendapat informasi yang benar dan jelas bilamana

terjadi insiden.

- 3) Berikan dukungan, pelatihan dan dorongan semangat kepada staf agar selalu terbuka kepada pasien dan keluarganya.

b. Untuk Tim/Unit

- 1) Pastikan tim anda menghargai dan mendukung keterlibatan pasien dan keluarganya bila telah terjadi insiden
- 2) Prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga bila mana terjadi insiden, dan segera berikan kepada mereka informasi yang jelas dan benar secara tepat
- 3) Pastikan, segera setelah kejadian, tim menunjukkan empati kepada pasien dan keluarganya.

6. Belajar dan Berbagi Pengalaman Tentang Keselamatan Pasien

Mendorong staf untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul.

Langkah penerapan:

a. Untuk Rumah Sakit:

- 1) Pastikan staf yang terkait telah terlatih untuk melakukan kajian insiden secara tepat, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab.
- 2) Kembangkan kebijakan yang menjabarkan dengan jelas kriteria pelaksanaan Analisis Akar Masalah (root cause analysis/RCA) yang mencakup insiden yang terjadi dan minimum satu kali per tahun melakukan Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) untuk proses risiko tinggi.

b. Untuk Unit/Tim:

- 1) Diskusikan dalam tim anda pengalaman dari hasil

analisis insiden.

- 2) Identifikasi unit atau bagian lain yang mungkin terkena dampak di masa depan dan bagilah pengalaman tersebut secara lebih luas.

7. Mencegah Cedera Melalui Implementasi Sistem Keselamatan Pasien

Menggunakan informasi yang ada tentang kejadian/masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Langkah Penerapan

a. Untuk RumahSakit:

- 1) Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem pelaporan, asesmen risiko kajian insiden dan audit serta analisis, untuk menentukan solusi setempat.
- 2) Solusi tersebut dapat mencakup penjabaran ulang sistem (struktur dan proses) penyesuaian pelatihan staf dan atau kegiatan klinis termasuk penggunaan instrumen yang menjamin keselamatan pasien.
- 3) Lakukan asesmen risiko untuk setiap perubahan yang direncanakan.
- 4) Sosialisasikan solusi yang dikembangkan oleh Komite Nasional Keselamatan Pasien RumahSakit.
- 5) Beri umpan balik kepada staf tentang setiap tindakan yang diambil atas insiden yang dilaporkan.

b. Untuk Unit/Tim:

- 1) Libatkan tim anda dalam mengembangkan berbagai cara untuk membuat asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman.
- 2) Telaah kembali perubahan-perubahan yang dibuat tim anda dan pastikan pelaksanaannya.
- 3) Pastikan tim anda menerima umpan balik atas setiap tindak lanjut tentang insiden yang dilaporkan.

B. Tujuh Langkah Keselamatan Pasien

Tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit merupakan panduan yang komprehensif untuk menuju keselamatan pasien, sehingga tujuh langkah tersebut secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit. Dalam pelaksanaan, tujuh langkah tersebut tidak harus berurutan dan tidak harus serentak. Pilih langkah-langkah yang paling strategis dan paling mudah dilaksanakan di rumah sakit. Bila langkah-langkah ini berhasil maka kembangkan langkah-langkah yang belum dilaksanakan. Bila tujuh langkah ini telah dilaksanakan dengan baik rumah sakit dapat menambah penggunaan metoda-metoda lainnya.

1. Standar 1. Hak Pasien

Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya kejadian tak diharapkan.

Kriteria:

- a. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan.
- b. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencanapelayanan.
- c. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan dan prosedur untuk pasien termasukkemungkinan KTD

2. Standar II. Mendidik Pasien dan Keluarga

Rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung pasien dalam asuhan pasien. Keselamatan pasien dalam pemberian pelayanan dapat di tingkatkan dengan

keterlibatan pasien yang merupakan patner dalam proses pelayanan.Karena itu di rumah sakit harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhanpasien.

Kriteria:

- a. Memberi informasi yang benar, jelas, lengkap danjujur.
- b. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga.
- c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti.
- d. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.
- e. Memetuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit
- f. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggangrasa
- g. Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati

3. Standar III. Keselamatan Pasien dan Kesiambungan Pelayanan.

Rumah sakit menjamin kesiambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan.

Kriteria:

- a. Terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar dari rumahsakit.
- b. Terdapat koordinasi pelayanan yang di sesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesiambungan sehingga pada seluruh tahap pelayanan transaksi antar unit pelayanan dapat berjalan baik dan 20ystem.

- c. Terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan 21system, konsultasi dan rujukan, pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjutlainnya.
- d. Terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman danefektif..

4. Standar IV:

Rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif , dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien.

Kreteria :

- a. Setiap Rumah sakit harus melakukanm proses perencanaan yang baik mengacu pada visi, misi dan tujuan rumah sakit, kebutuhan pasien petugas pelayanan Kesehatan kaidah klinis terkini praktis bisnis yang sehat dan factor factor lain yang berpotensi resoikop bagi pasien sesuai dengan "Langkah menuju keselamatan pasieb di rumah sakit"
- b. Setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja antara lain yang terkait dengan : pelaporan insiden, akreditasi, manajemen resiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan.
- c. Setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua KTD/KNC, dan secara proaktif melakukan evaluasi suatu proses kasus resikotinggi.
- d. Setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan

perubahan System yang di perlukan, agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin.

5. Standar V. Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien.

- a. Pimpinan mendorong menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan "7 langkah menuju keselamatan pasien rumahsakit".
- b. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi KTD/KNC.
- c. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien.
- d. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien.
- e. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja Rumah Sakit dan keselamatan pasien.

Kriteria:

- a. Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien.
- b. Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden, yang mencakup jenis kejadian yang memerlukan perhatian, mulai dari KNC (Near miss) sampai dengan KTD (Adverse event).
- c. Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari rumah sakit terintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan pasien.

- d. Tersedia prosedur "cepat tanggap" terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis.
- e. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas tentang analisis akar masalah (RCA) kejadian pada saat program keselamatan pasien mulai dilaksanakan.
- f. Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden atau kegiatan proaktif untuk memperkecil resiko, termasuk mekanisme untuk mendukung staf dalam kaitan dengan kejadian.
- g. Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar unit dan antar pengelola pelayanan di dalam Rumah Sakit dengan pendekatan antardisiplin.
- h. Tersedia sumber daya dan System informasi yang di butuhkan dalam kegiatan perbaikan kinerja rumah sakit dan perbaikan
- i. Keselamatan Pasien, termasuk evaluasi berkala terhadap kecukupan sumber daya tersebut.
- j. Tersedia sasaran terukur dan pengumpulan informasi menggunakan criteria obyektif untuk mengevaluasi efektifitas perbaikan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien, termasuk rencana tindak lanjut dan implementasinya.

6. Standar VI. Mendidik Staf Tentang Keselamatan Pasien.

- a. Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas.

- b. Rumah sakit menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien.

Kriteria:

- a. Setiap rumah sakit harus memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi staf baru yang memuat System tentang keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- b. Setiap rumah sakit harus mengintegrasikan 24 jam keselamatan pasien dalam setiap kegiatan inservice training dan member pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden.
- c. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok guna mendukung pendekatan interdisiplin dan kolaboratif dalam rangka melayani pasien

7. Standar VII. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

- a. Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal
- b. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat.

Kriteria

- a. Perlu di sediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait dengan keselamatan pasien.
- b. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada.

C. Sasaran Keselamatan Pasien

Sasaran Keselamatan Pasien merupakan syarat untuk diterapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Penyusunan sasaran ini mengacu kepada Nine Life-Saving Patient Safety Solutions dari WHO Patient Safety (2007) yang digunakan juga oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit PERSI (KKPRS PERSI), dan dari Joint Commission International (JCI). Maksud dari Sasaran Keselamatan Pasien adalah mendorong perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran menyoroti bagian-bagian yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan dan menjelaskan bukti serta solusi dari konsensus berbasis bukti dan keahlian atas permasalahan ini. Diakui bahwa desain system yang baik secara intrinsik adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu tinggi, sedapat mungkin sasaran secara umum difokuskan pada solusi-solusi yang menyeluruh. Enam sasaran keselamatan pasien adalah tercapainya hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran I : Ketepatan Identifikasi Pasien

a. Standar SKP 1

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki/ meningkatkan ketelitian Identifikasi Pasien

b. Maksud dan Tujuan Sasaran I

Kesalahan karena keliru dalam mengidentifikasi pasien dapat terjadi di hampir semua aspek/tahapan diagnosis dan pengobatan .Kesalahan identifikasi pasien bisa terjadi pada pasien yang dalam keadaan terbius/tersedasi, mengalami disorientasi, tidak sadar, bertukar tempat tidur/kamar/ lokasi di rumah sakit, adanya kelainan sensori, atau akibat situasi lain.

Maksud sasaran ini adalah untuk melakukan dua kali pengecekan yaitu: pertama, untuk identifikasi pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan atau pengobatan; dan kedua, untuk kesesuaian pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut. Kebijakan dan/ atau prosedur yang secara kolaboratif dikembangkan untuk memperbaiki proses identifikasi, khususnya pada proses untuk mengidentifikasi pasien ketika pemberian obat, darah, atau produk darah. Pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis; atau pemberian pengobatan atau tindakan lain. Kebijakan dan/atau prosedur memerlukan sedikitnya dua cara untuk mengidentifikasi seorang pasien, seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang identitas pasien dengan bar-code, dan lain-lain. Nomor kamar pasien atau lokasi tidak bisa digunakan untuk identifikasi. Kebijakan dan/atau prosedur juga menjelaskan penggunaan dua identitas berbeda di lokasi yang berbeda di rumah sakit, seperti di pelayanan rawat jalan, unit gawat darurat, atau ruang operasi termasuk identifikasi pada pasien koma tanpa identitas. Suatu proses kolaboratif digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan/atau prosedur agar dapat memastikan semua kemungkinan situasi untuk dapat diidentifikasi.

c. Elemen Penilaian Sasaran I

- 1) Pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien, tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasipasien.
- 2) Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produkdarah.

- 3) Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan System lain untuk pemeriksaan klinis.
- 4) Pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan/prosedur.
- 5) Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi.

2. Sasaran II: Peningkatan Komunikasi Yang Efektif

a. Standar SKP II

Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar para pemberi layanan.

b. Maksud dan Tujuan Sasaran II

Komunikasi efektif, yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh pasien, akan mengurangi kesalahan, dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi dapat berbentuk elektronik, lisan, atau tertulis. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan kebanyakan terjadi pada saat perintah diberikan secara lisan atau melalui telepon. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan yang lain adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis, seperti melaporkan hasil laboratorium klinik cito melalui telepon ke unit pelayanan. Rumah sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk perintah lisan dan telepon termasuk: mencatat (atau memasukkan ke komputer) perintah yang lengkap atau hasil pemeriksaan oleh penerima perintah; kemudian penerima perintah membacakan kembali (read back) perintah atau hasil pemeriksaan; dan mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dituliskan dan dibaca ulang adalah akurat.

Kebijakan dan/atau prosedur pengidentifikasian juga menjelaskan bahwa diperbolehkan tidak melakukan pembacaan kembali (read back) bila tidak memungkinkan seperti di kamar operasi dan situasi gawat darurat di IGD atau ICU.

c. Elemen Penilaian Sasaran II

- 1) Perintah lengkap secara lisan dan yang melalui telepon atau hasil pemeriksaandituliskan secara lengkap oleh penerimaperintah.
- 2) Perintah lengkap lisan dan telpon atau hasil pemeriksaan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerimaperintah.
- 3) Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh pemberi perintah atau yang menyampaikan hasilpemeriksaan
- 4) Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan verifikasi keakuratan komunikasi lisan atau melalui telepon secara konsisten.

3. Sasaran III Peningkatan Keamanan Obat Yang Perlu Diwaspadai (High-Alert)

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai (high-alert).

a. Maksud dan Tujuan Sasaran III

Bila obat-obatan menjadi bagian dari rencana pengobatan pasien, manajemen harus berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien. Obat-obatan yang perlu di waspada i(high- alert medications) adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (sentinel event), obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (adverse outcome) seperti obat-obat

yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau Look Alike Soun Alike/LASA). Obat-obatan yang sering disebutkan dalam isu keselamatan pasien adalah pemberian elektrolit konsentrat secara tidak sengaja (misalnya, kaliumk lorida 2 meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0.9%, dan magnesium sulfat = 50% atau lebih pekat). Kesalahan ini bisa terjadi bila perawat tidak mendapatkan orientasi dengan baik di unit pelayanan pasien, atau bila perawat kontrak tidak diorientasikan terlebih dahulu sebelum ditugaskan, atau pada keadaan gawat darurat. Cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut adalah dengan meningkatkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai termasuk memindahkan elektrolit terlebih dahulu sebelum ditugaskan, atau pada keadaan gawat darurat. Cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut adalah dengan meningkatkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan pasien kefarmasi. Rumah sakit secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk membuat daftar obat-obat yang perlu diwaspadai berdasarkan data yang ada di rumah sakit. Kebijakan dan/atau prosedur juga mengidentifikasi area mana saja yang membutuhkan elektrolit konsentrat, seperti di IGD atau kamar operasi, serta pemberian label secara benar pada elektrolit dan bagaimana penyimpanannya di area tersebut, sehingga membatasi akses, untuk

mencegah pemberian yang tidak sengaja/kuranghati-hati.

Elemen Penilaian Sasaran III

- a. Kebijakan dan /atau prosedur dikembangkan agar memuat proses identifikasi, menetapkan lokasi, pemberian label, dan penyimpanan elektrolit konsentrat.
- b. Implementasi kebijakan dan prosedur.
- c. Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang kurang hati-hati di area tersebut sesuai kebijakan.
- d. Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit pelayanan pasien harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (restricted).

4. Sasaran IV: Kepastian Tepat-Lokasi Tepat-Prosedure Tepat Pasien Operasi.

- a. Standar SKP IV.
Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memastikan tepat lokasi, tepat-prosedur dan tepat pasien.
- b. Maksud dan Tujuan Sasaran IV
Salah lokasi, salah-prosedur, pasien-salah pada operasi, adalah sesuatu yang menkhawatirkan dan tidak jarang terjadi dirumah sakit. Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau yang tidak adekuat antara anggota tim bedah, kurang/tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi (site marking), dan tidak ada prosedur untuk verifikasi Lokasi operasi. Di samping itu, asesmen pasien yang tidak adekuat, penelaahan ulang catatan medis tidak adekuat, budaya yang tidak mendukung komunikasi

terbuka antar anggota tim bedah, permasalahan yang berhubungan dengan tulisan tangan yang tidak terbaca (illegible handwriting) dan pemakaian singkatan adalah faktor-faktor kontribusi yang sering terjadi. Rumah sakit perlu untuk secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur yang efektif di dalam mengeliminasi masalah yang mengkhawatirkan ini. Digunakan juga praktek berbasis bukti, seperti yang digambarkan di Surgical Safety Checklist dari WHO Patient Safety (2009), juga di The Joint Commission's Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedure, Wrong Person Surgery. Penandaan lokasi operasi perlu melibatkan pasien dan dilakukan atas satu pada tanda yang dapat dikenali. Tanda itu harus digunakan secara konsisten di rumah sakit dan harus dibuat oleh operator/orang yang akan melakukan tindakan, dilaksanakan saat pasien terjaga dan sadar jika memungkinkan, dan harus terlihat sampai saat akan disayat. Penandaan lokasi operasi dilakukan pada semua kasus termasuk sisi (laterality), multipel struktur (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multipel level (tulang belakang).

Maksud proses verifikasi praoperatif adalah untuk :

- memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar;
- memastikan bahwa semua dokumen, foto (imaging), hasil pemeriksaan yang relevan tersedia, diberi label dengan baik, dan dipampang; dan
- melakukan verifikasi ketersediaan peralatan khusus dan/atau implant² yang dibutuhkan. Tahap "Sebelum insisi" (Time out) memungkinkan semua pertanyaan atau kekeliruan diselesaikan. Time out

dilakukan di tempat, dimana tindakan akan dilakukan, tepat sebelum tindakan dimulai, dan melibatkan seluruh tim operasi. Rumah sakit menetapkan bagaimana proses itu didokumentasikan secara ringkas, misalnya menggunakan checklist

c. Elemen Penilaian Sasaran IV

- 1) Rumah sakit menggunakan suatu tanda yang jelas dan dimengerti untuk identifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien di dalam proses penandaan.
- 2) Rumah sakit menggunakan suatu checklist atau proses lain untuk memverifikasi saat preoperasi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat, dan fungsional.
- 3) Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat prosedur "sebelum insisi/time-out" tepat sebelum dimulainya suatu prosedur/tindakan pembedahan.
- 4) Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mendukung proses yang seragam untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, termasuk prosedur medis dan dental yang dilaksanakan di luar kamar operasi.

5. Sasaran V: Pengurangan Risiko Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan

a. Standar SKP V

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan.

b. Maksud dan Tujuan Sasaran V

Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan

tantangan terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan, dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional pelayanan kesehatan. Infeksi biasanya dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan termasuk infeksi saluran kemih, infeksi pada aliran darah (blood stream infections) dan pneumonia (sering kali dihubungkan dengan ventilasi mekanis). Pusat dari eliminasi infeksi ini maupun infeksi-infeksi lain adalah cuci tangan (hand hygiene) yang tepat. Pedoman hand hygiene bisa dibaca kepustakaan WHO, dan berbagai organisasi nasional dan internasional. Rumah sakit mempunyai proses kolaboratif untuk mengembangkan kebijakan dan/atau prosedur yang menyesuaikan atau mengadopsi petunjuk hand hygiene yang diterima secara umum dan untuk implementasi petunjuk itu di rumah sakit.

c. Elemen Penilaian Sasaran V

- 1) Rumah sakit mengadopsi atau mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum (al.dari WHO Patient Safety).
- 2) Rumah sakit menerapkan program hand hygiene yang efektif.
- 3) Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan risiko dari infeksi yang terkait

6. Sasaran VI: Pengurangan Resiko Pasien Jatuh

a. Standar SKP VI

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh.

b. Maksud dan Tujuan Sasaran VI

Jumlah kasus jatuh cukup bermakna sebagai penyebab cedera bagi pasien rawat inap. Dalam konteks populasi/masyarakat yang dilayani, pelayanan yang disediakan, dan fasilitasnya, rumah sakit perlu mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa termasuk riwayat jatuh, obat dan telaah terhadap konsumsi alkohol, gaya jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Program tersebut harus diterapkan rumah sakit.

c. Elemen Penilaian Sasaran VI

- 1) Rumah sakit menerapkan proses asesmen awal atas pasien terhadap risiko jatuh dan melakukan asesmen ulang pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan, dan lain-lain.
- 2) Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko jatuh.
- 3) Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh dan dampak dari kejadian tidak diharapkan.
- 4) Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan berkelanjutan risiko pasien cedera akibat jatuh di rumah sakit

BAB 4

PERAN PERAWAT DALAM KESELAMATAN PASIEN

Perawat sebagai tenaga kesehatan yang system dan merupakan tenaga Kesehatan terbesar yang ada di rumah sakit mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keselamatan pasien. Perawat berperan dalam melindungi, melakukan promosi dan mencegah terjadinya sakit dan injury, mengurangi penderitaan melalui system dan pengobatan, serta melindungi dalam perawatan individu, keluarga, komunitas dan populasi (ANA, 2003).

Perawat mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Patient safety di rumah sakit yaitu sebagai pemberi pelayanan keperawatan. Perawat harus mematuhi semua standar pelayanan dan SOP yang telah dibuat dan ditetapkan oleh rumah sakit serta tidak luput pula dalam menerapkan prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikan, menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian yang tidak diharapkan, melakukan pendokumentasian dengan benar dari semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga serta komunikasi efektif yang merupakan hal yang sangat berperan terhadap keberhasilan suatu pelayanan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya.

Berdasarkan Peraturan menteri kesehatan Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan terhadap kejadian tidak diinginkan di fasilitas pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang Kembali.

Penekanan lebih lanjut sesuai dijelaskan dalam undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Adapun karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh berbagai macam perkembangan, baik itu perkembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan, kemajuan teknologi, maupun kehidupan 36system ekonomi kemarakatan.

Tenaga kesehatan yang mempunyai peran penting dalam keselamatan pasien salah satunya adalah perawat. Keperawatan merupakan tenaga professional yang memiliki peranan penting dalam fungsi rumahsakit. Perawat memiliki peranan penting sebagai komponen dalam pelaporan kesalahan pelayanan dalam pengembangan program keselamatan pasien di rumah sakit. Tidak dipungkiri bahwasanya perawat berperan penting dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit. Keselamatan pasien merupakan hal yang lebih penting di bandingkan dengan efisiensi pelayanan.

Isu global yang saat ini sangat penting dalam pelayanan kesehatan adalah keselamatan pasien (*patient safety*). Isu ini praktis mulai dibicarakan kembali pada tahun 2000an, sejak laporan dari *Institute of Medicine (IOM)* yang menerbitkan laporan : *To err is human, building a safer health system*, yang memuat data menarik tentang Kejadian Tidak Diharapkan/ KTD (*Adverse Event*). Organisasi kesehatan dunia (WHO) juga telah

menegaskan pentingnya keselamatan dalam pelayanan kepada pasien sehubungan dengan data KTD di Rumah Sakit di berbagai 37ystem menunjukkan angka yang tidak kecil berkisar 3 – 16%. Sangat perlu adanya Gerakan keselamatan pasien dalam konteks pelayanan kesehatan saat ini diterima secara luas di seluruh dunia. WHO kemudian meluncurkan program *World Alliance for Patient Safety* pada tahun 2004. Di dalam program itu dikatakan bahwa keselamatan pasien adalah prinsip fundamental pelayanan pasien sekaligus komponen kritis dalam manajemen mutu.

Rumah Sakit Wajib Menerapkan Standar Keselamatan Pasien, sesuai dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 43 : antara lain berisikan :

1. Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.
2. Rumah Sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara 37ystem dan ditujukan untuk mengkoreksi 37ystem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melalui 37ystem ini tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Keberhasilan

Sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan diantaranya perawat, dokter atau tim kesehatan lain yang satu dengan yang lain saling menunjang. Sistem ini akan memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif dengan melihat nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Dalam pelayanan kesehatan, para perawat diharapkan juga dapat memberikan pelayanan secara berkualitas.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit diberikan melalui bentuk perawatan dan tindakan sistem. Tenaga kesehatan dalam hal ini bertanggung jawab terhadap pengobatan dan perawatan yang dilakukan, salah satu tenaga kesehatan disini adalah perawat. Perawat merupakan komponen penting dan strategis dalam pelayanan kesehatan yaitu di Rumah sakit. Kehadiran dan peran perawat tidak dapat diabaikan, dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang perawat dituntut untuk memahami proses dan standar praktik perawat. Untuk menjaga *Patient Safety* salah satunya dengan menjaga kompetensi perawat yang melakukan tindakan keperawatan tertentu. Oleh karena sistem tersebut pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya. Pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, standar prosedur operasional sistem etik, agar masyarakat sebagai pasien dapat merasakan pelayanan yang profesional yang diberikan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien disebutkan bahwa;

"Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko,

identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil”.

Pelaksanaan mewujudkan *Patient Safety*: khususnya profesi perawat dalam melaksanakan Praktik keperawatan berkewajiban memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standard prosedur operasional, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pentingnya pemahaman perawat tentang perannya dalam pelayanan keperawatan kepada pasien, sehingga perawat harus membekali dirinya dengan materi-materi manajemen pasien Safety sehingga dalam implementasi asuhan Keperawatan. Upaya – upaya pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien penekanan pada pelaporan kejadian yang merugikan pasien, pencegahan terhadap kesalahan medis dan pencegahan perawatan yang dapat merugikan kesehatan. Kejadian yang merugikan tersebut dapat terjadi dalam tahap diagnosis, tidak menerapkan pemeriksaan yang sesuai, melakukan tindakan keperawatan tidak sesuai standar pelayanan operasional. Sedangkan pada tahap pengobatan seperti kesalahan pada prosedur pengobatan, pelaksanaan terapi, metode penggunaan obat dan keterlambatan merespon hasil pemeriksaan. Oleh karena itu pelayanan keperawatan merupakan sesuatu hal yang penting dalam mewujudkan keselamatan pasien (*Patient Safety*) namun masih banyak yang terjadi kejadian yang dapat merugikan pasien.

Masih ada kejadian merugikan pasien yang ada di rumah sakit perlu adanya monitoring dalam pelaksanaan sehingga perlu dilakukan dalam penancangan program Keselamatan pasien (*Patient Safety*). Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera di fasilitas pelayanan kesehatan maka diperlukan standar keselamatan pasien. **Perawat harus menyadari perannya** sehingga harus dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan *Patient Safety*. Metode tim dalam keperawatan perlu menjadi strategi dalam penanganan *Patient Safety*, karena metode tim ini memungkinkan pelayanan keperawatan yang menyeluruh dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap sekelompok pasien. Pemberian asuhan keperawatan yang menyeluruh kepada pasien diharapkan keselamatan pasien dapat diperhatikan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan khususnya Asuhan layanan keperawatan .

Pelaksanaan *Patient Safety* butuh upaya dan kerjasama berbagai pihak, *Patient Safety* merupakan upaya dari seluruh komponen sarana pelayanan kesehatan, dan perawat memegang peran kunci untuk tercapainya pendekatan personal.

Pendekatan ini memfokuskan pada tindakan yang tidak aman, melakukan dan pelanggaran prosedur, dari orang-orang yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan (dokter, perawat, ahli bedah, yang buruk, tidak hati-hati, alpa dan sembrono. Selain itu juga semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik perawat, semakin dapat menjamin mutu praktik dan keselamatan klien dalam asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Ahli anestesi, farmasis dan lain – lain). Tindakan tidak aman ini dianggap berasal dari proses

mental yang menyimpang seperti mudah lupa, kurang perhatian, motivasi yang buruk, tidak hati-hati, alpa dan sembrono. Selain itu juga semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik perawat, semakin dapat menjamin mutu praktik dan keselamatan klien dalam asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa Rumah sakit di Indonesia menyimpulkan bahwa salah satunya adalah tindakan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat belum semuanya sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada. Sebagai contoh, masih ada beberapa perawat yang dalam melakukan pergantian jaga belum melakukan dengan 41system komunikasi SBAR (*Situation, Background, Assesment, Recommendation*) meskipun dari pihak Rumah sakit sudah menerapkan 41system komunikasi SBAR. Beberapa perawat masih mementingkan keselamatan dirinya sendiri, misalnya dalam melakukan tindakan mencuci tangan dilakukan setelah kontak dengan pasien saja meskipun sudah ada SOP di setiap ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perawat masih belum menjaga keselamatan pasien secara optimal sesuai dengan SOP yang telah ada di Rumah Sakit.

A. Peran Perawat Dalam Mewujudkan Penerapan Patient Safety Di Rumah Sakit

Patient Safety (Keselamatan Pasien) merupakan suatu dimana rumah sakit memberikan asuhan pasien lebih aman, mencegah terjadinya kejadian tidak diharapkan yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan pelayanan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Dari definisi inilah, kita

dapat mengetahui peran perawat dalam mewujudkan patient safety di rumah sakit yaitu:

1. Sebagai pemberi pelayanan keperawatan, perawat mematuhi standar pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan.
2. Menerapkan komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarganya.
3. Peka, proaktif dan melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian tidak diharapkan (KTD).
4. Serta mendokumentasikan dengan benar semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga. Menerapkan prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan.
5. Memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikan.
6. Menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam pemberian pelayanan Kesehatan.

Peran Perawat di Rumah sakit menurut konsorsium Ilmu Kesehatan di jelaskan bahwa peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, advokasi pasien, pendidik, konsultasi dan *research* yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberi Asuhan keperawatan

Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan.

2. Peran sebagai advokat pasien

Peran ini dilakukan perawat dalam membantu pasien dan keluarganya dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan pasien. Juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi pelayanan sebaik-baiknya, informasi tentang penyakitnya dan privasi.

3. Peran educator

Bentuk peran perawat selain di tinjau dari peran juga dapat ditinjau dari peranan fakultatif. Pelaksanaan peran fakultatif yang dilakukan oleh perawat yaitu melaksanakan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Pendidikan kesehatan dilakukan apabila pasien belum mengerti tentang penyakitnya dan kondisi kesehatannya. Menyampaikan kepada pasien tentang Hak dan Kewajiban dalam pelayanan kesehatan. Peran ini dilakukan dengan membantu pasien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari pasien setelah dilakukan pendidikan Kesehatan.

4. Peran coordinator

Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan pasien.

5. Peran kolaborator

Peran perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter,

fisioterapis, ahli gizi dan lainlain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya.

6. Peran konsultan

Di sini perawat berperan sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau Tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan pasien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan.

7. Peran pembaharu

Peran ini dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerja sama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Peran seorang perawat dalam kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit sangat tergantung dari kebijakan rumah sakit dalam menegakkan peraturan, perawat merupakan salah satunya perkerja yang fulltime atau penuh mendampingi pasien dirumah sakit. Perawat merupakan garda terdepan bersama dengan tenaga medis lainnya dalam melakukan pertolongan pada pasien dari pasien datang sampai pasien Kembali pulang dijaga dengan keselamatannya dengan menggunakan *manajemen Pasien Safety* sebagai guide dalam melakukan asuhan keperawatan.

Selain peran-peran yang telah di jelaskan diatas, perawat memiliki peran penting dalam kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit yaitu sebagai berikut :

1. Membantu dokter dalam menyusun rencana kerja untuk peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja;
2. Melaksanakan program kerja yang telah di sepakati;

3. Memelihara dan mempertinggi mutu pelayanan perawatan dan pengobatan;
4. Memelihara alat alat perawatan, obat obatan dan fasilitas Kesehatan;
5. Memperkecil angka kecelakaan dirumah sakit;
6. Membantu menentukan kasus dari penderita membantu dokter melakukan pemeriksaan kesehatan yang merujuk dengan penyembuhan;
7. Ikut menilai keadaan kesehatan tenaga kerja di hubungkan dengan 45system perkerjaan dan melaporkan kepada dokter;
8. Membantu usaha perbaikan kesehatan lingkungan dan rumah sakit sesuai kemampuan yang ada;
9. Mengambil peranan dalam usaha meminimalkan kecelakaan;
10. Membantu merencanakan kunjungan;
11. Menyelenggarakan pendidikan hiperkes kepada tenaga kerja yang dilayani;
12. Turut ambil bagian dalam usaha keselamatan kerja;
13. Memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit;
14. Memelihara hubungan dengan perawat guna meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit;
15. Memberikan pelatihan ronde keperawatan tentang ketrampilan pemberian asuhan Keperawatan;

Dalam Manajemen Pasien Safety, Kewajiban yang sangat penting berkaitan dengan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal adalah ketentuan tentang keselamatan pasien⁸. Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa:

1. Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.
2. Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelaporan insiden,
 - b. menganalisa, dan
 - c. menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka pelaksanaan *Patient Safety* butuh upaya dan kerjasama berbagai pihak, *Patient Safety* merupakan upaya dari seluruh komponen sarana pelayanan kesehatan, dan perawat memegang peran kunci untuk tercapainya pendekatan personal. Pendekatan ini memfokuskan pada tindakan yang tidak aman, melakukan dan pelanggaran prosedur, dari orang-orang yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan (dokter, perawat, ahli bedah, ahli anestesi, farmasis dan lain – lain). Tindakan tidak aman ini dianggap berasal dari proses mental yang menyimpang seperti mudah lupa, kurang perhatian, motivasi yang buruk, tidak hati-hati, alpa dan sembrono. Selain itu juga semakin lengkap standar profesi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik perawat, semakin dapat menjamin mutu praktik dan keselamatan klien dalam asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat.

Dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit melibatkan beberapa tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan diantaranya dokter, perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan lain yang mendukung dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien. Perawat memiliki kedudukan sebagai salah satu anggota Tim Komite Keselamatan pasien, dimana tugas dan tanggungjawabnya

sebagai pemberi asuhan keperawatan dalam pelayanan kesehatan. Asuhan keperawatan yang diterapkan harus berdasarkan enam sasaran keselamatan pasien sehingga mendukung dalam pelaksanaan program dari Tim Komite Keselamatan Pasien. Prosedur pelaksanaan peran perawat harus sudah mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIKP (Surat Ijin Kerja Perawat) secara preventif menjadi persyaratan sebagai perawat yang 47system4747e47al sesuai dengan kompetensinya. Pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu keperawatan. Sehingga perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan secara aman karena dengan bukti tersebut menyatakan bahwa perawat sudah dinyatakan kompetensi sesuai dengan profesinya dan mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan keperawatan.

B. Faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien

Rumah sakit sebagai salah satu organisasi penyedia fasilitas kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upayaprogram keselamatan pasien, maka diperlukan suatu 47system yang aman untuk menghindari resiko terjadinya kesalahan dalam penerapan teknologi Kesehatan. Perawat berperan penting dalam memastikan keselamatan pasien dengan memantau kondisi pasien untuk mencegah terjadinya insiden, memberikan pendidikan kesehatan, mendeteksi kesalahan dan nyaris cedera, serta melakukan tugas-tugas lain untuk memastikan pasien menerima perawatan yang berkualitas tinggi, tidak hanya itu Perawat juga berperan sebagai pemberi pelayanan dan

mendampingi pasien 24 jam yang secara teratur berinteraksi dengan dokter, apoteker, keluarga dan tim kesehatan lain. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang menjadi isu internasional dan nasional yaitu keselamatan pasien. Keselamatan pasien menjadi bagian penting dalam pelayanan keperawatan karena keselamatan pasien merupakan suatu ⁴⁸system⁴⁸ untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan yang berdampak pada pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan keselamatan pasien telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit menjelaskan bahwa setiap rumah sakit yang ada di Indonesia wajib untuk menerapkan keselamatan pasien. Keselamatan pasien menjadi isu terkini karena makin meningkatnya kejadian tidak diharapkan (KTD) atau *adverse event*. Insiden keselamatan pasien di rumah sakit akan memberikan dampak yang merugikan bagi pihak rumah sakit, staf dan pasien pada khususnya karena sebagai penerima pelayanan. Dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terjadi akibat rendahnya kualitas dan mutu asuhan yang diberikan. Tujuan nya adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan enam sasaran keselamatan pasien oleh perawat dalam mencegah *adverse event* di Rumah Sakit.

Adverse event merupakan suatu peristiwa yang dapat menyebabkan hal yang tak terduga atau tidak diinginkan sehingga membahayakan keselamatan pengguna alat kesehatan termasuk pasien atau orang lain. Klasifikasi *adverse event* adalah kejadian nyaris cedera (KNC), kejadian tidak cedera (KTC) dan sentinel (kematian atau cedera).

Contoh dari KTD seperti medication error, flebitis, infeksi daerah operasi, dan pasien jatuh dengan cidera.

Jadi upaya yang dilakukan rumah sakit untuk menekan insiden keselamatan pasien adalah dengan membentuk komite keselamatan pasien rumah sakit yang memiliki program antara lain memenuhi standar keselamatan pasien, program tujuh langkah menuju keselamatan rumah sakit, dan penerapan sasaran keselamatan pasien. Dengan penerapan sasaran keselamatan pasien yang baik maka akan tercipta pelayanan yang paripurna. Banyak faktor yang mempengaruhi sasaran keselamatan pasien, antara lain: karakteristik petugas berupa usia, lama kerja, Tingkat pengetahuan, motivasi, fasilitas, struktur organisasi budaya organisasi mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Namun, dalam proses pencapaiannya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain tingkat pengetahuan perawat, sikap perawat, serta fasilitas rumah sakit.

Faktor yang mempengaruhi peran perawat dalam pelaksanaan *Patient Safety* dan perlindungan hak pasien di Rumah Sakit ada beberapa faktor antara lain:

1. Faktor yuridis

Dalam memberikan pelayanannya Rumah sakit sebagai sebuah institusi diatur dalam Undang- Undang Rumah Sakit, dimana terdapat empat pasal dalam undang-undang tersebut yang mengamankan keselamatan pasien. Amanah keselamatan pasien dalam Undang-Undang Rumah Sakit telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan pasien. (Basabih, 2017 :150-157). Serta Undang-undang lain:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 53 (3) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan keselamatan nyawa pasien;
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32n yang menyatakan bahwa pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
- d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan tersebut telah mempengaruhi perawat dalam melaksanakan perannya untuk pelaksanaan *Patient Safety*. Meskipun masih ada beberapa perawat yang belum memahami peraturan dengan baik sehingga dalam melakukan pelayanan belum maksimal.

2. Faktor Sosial

Faktor yang memengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit adalah budaya organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi niat untuk melaporkan kejadian keselamatan pasien. Faktor-faktor lain yang memengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit, antara lain:

- a. Karakteristik petugas, seperti usia, lama kerja, tingkat pengetahuan, dan motivasi;
- b. Supervisi
- c. Fasilitas
- d. Struktur organisasi

Keselamatan pasien adalah yang dibuat rumah sakit untuk membuat asuhan pasien lebih aman. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan dalam tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

3. Faktor teknis

Faktor tersebut ada yang mendukung yang menghambat. Adapun yang mendukung diantaranya Faktor yuridis yaitu peraturan – peraturan yang memuat ketentuan bahwa mewajibkan perawat untuk melakukan pelaksanaan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) sudah ada. Peraturan tersebut telah mempengaruhi perawat dalam melaksanakan perannya untuk pelaksanaan *Patient Safety*. Meskipun masih ada beberapa perawat yang belum memahami peraturan dengan baik sehingga dalam melakukan pelayanan belum maksimal. Faktor-faktor teknis ini lebih kepada pelaksanaan yang mendukung di lapangan dalam mempraktekkan bagaimana seluruh elemen pegawai medis dan non medis mendukung terlaksananya pelaksanaan Keselamatan Pasien. Khususnya perawat harus membekali diri terkait dengan knowledge mengenai seluruh pemahaman tentang keselamatan pasien dan juga peningkatan profesionalisme dalam hal ini skill atau motoriknya dalam melaksanakan Tindakan harus benar-benar sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

BAB 5

ASUHAN KEPERAWATAN DALAM KESELAMATAN PASIEN

A. Keselamatan Pasien

1. Pengertian Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien terbentuk dari kompleksitas dalam pelayanan kesehatan dan peningkatan cedera pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien berperan penting dalam pencegahan dan penurunan risiko, eror dan cedera yang dapat terjadi selama proses pelayanan (WHO, 2017; Galleryzki *et al*, 2021).

Keselamatan pasien merupakan salah satu dimensi mutu yang saat ini menjadi pusat perhatian para praktisi pelayanan kesehatan dalam skala nasional maupun internasional. Penerapan program keselamatan pasien di rumah sakit merupakan hal yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak factor (Limbong, 2018). Asuhan keperawatan bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara perawat dengan klien. Untuk itu, adanya asuhan keperawatan dapat meningkatkan kemandirian perawat dalam mengerjakan tugasnya. Asuhan keperawatan adalah proses kegiatan pada praktik keperawatan yang secara langsung ditujukan kepada klien atau pasien di berbagai pelayanan kesehatan. Setelah itu, keperawatan akan melaksanakan profesinya

namun berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan dan ilmu serta kiat keperawatan yang bersifat *humanistic* dan juga berdasarkan pada kebutuhan objektif klien untuk menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi klien.

Keselamatan Pasien Dalam UU No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 43:

- a. RS wajib menerapkan Standar Keselamatan Pasien;
- b. Standar Keselamatan Pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka Kejadian Tidak Diharapkan (KTD);
- c. RS melaporkan kegiatan ayat 2 kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan Menteri;
- d. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) pada ayat 2 dibuat secara dan ditujukan untuk mengoreksi dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan pasien ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/Per/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Pasal 6:
 - 1) Setiap rumah sakit wajib membentuk Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit (TKPRS) yang ditetapkan oleh kepala rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan keselamatan pasien;
 - 2) TKPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit;
 - 3) Keanggotaan TKPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari manajemen rumah sakit dan unsur dari profesi sehatan di rumah sakit.
 - 4) TKPRS melaksanakan tugas:

- a) Mengembangkan program keselamatan pasien di rumah sakit sesuai dengan kekhususan rumah sakit tersebut;
- b) Menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit;
- c) Menjalankan peran untuk melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) tentang terapan (implementasi) program keselamatan pasien rumah sakit;
- d) Bekerja sama dengan bagian pendidikan dan pelatihan rumah sakit untuk melakukan pelatihan internal keselamatan pasien rumah sakit;
- e) Melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisa insiden serta mengembangkan solusi untuk pembelajaran;
- f) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala rumah sakit dalam rangka pengambilan kebijakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- g) Membuat laporan kegiatan kepada kepala rumah sakit.

2. Tujuan Keselamatan Pasien

- a. Tujuan system keselamatan pasien rumah sakit adalah:
 - 1) Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan Masyarakat;
 - 3) Menurun nya kejadian tak diharapkan (KTD) di rumah sakit;

- 4) Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi penanggulangan KTD
- b. Adapun Tujuan kegiatan patient safety di rumah sakit (Dirjen Yanmed RI, 2008) sebagai berikut:
 - 1) Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan Masyarakat;
 - 3) Menurunnya kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit;
 - 4) Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.
- c. Sedangkan tujuan keselamatan pasien secara internasional adalah:
 - 1) *Identify patients correctly* (mengidentifikasi pasien secara benar)
 - 2) *Improve effective communication* (meningkatkan komunikasi yang efektif)
 - 3) *Improve the safety of high-alert medications* (meningkatkan keamanan dari pengobatan resiko tinggi);
 - 4) *Eliminate wrong-site, wrong-patient, wrong procedure surgery* (mengeliminasi kesalahan penempatan, kesalahan pengenalan pasien, kesalahan prosedur operasi);
 - 5) *Reduce the risk of health care associated infections* (mengurangi risiko infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan);
 - 6) *Reduce the risk of patient harm from falls* (mengurangi risiko pasien terluka karena jatuh);

3. Manfaat Keselamatan Pasien

Program keselamatan pasien ini memberikan berbagai manfaat bagi rumah sakit antara lain:

- a. Adanya kecenderungan "*Green Product*" produk yang aman di bidang industry lain seperti halnya menjadi persyaratan dalam berbagai proses transaksi, sehingga suatu produk menjadi semakin laris dan dicari masyarakat.
- b. Rumah Sakit yang menerapkan keselamatan pasien akan lebih mendominasi pasar jasa bagi Perusahaan-perusahaan dan Asuransi-asuransi dan menggunakan Rumah Sakit tersebut sebagai provider kesehatan karyawan/klien mereka, dan kemudian di ikuti oleh masyarakat untuk mencari Rumah Sakit yang aman;
- c. Kegiatan Rumah Sakit akan lebih memfokuskan diri dalam kawasan keselamatan pasien.

4. Sasaran Keselamatan Pasien

Sasaran pasien merupakan syarat yang harus diterapkan di semua rumah sakit yang telah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi, Rumah Sakit (KARS). Penyusunan sasaran ini mengacu pada *Nine Life-Saving Patient Safety Solution* dari WHO Patient Safety 2007; yang juga digunakan oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS PERSI) dari *Joint Comission International* (JCI). Sasaran keselamatan pasien mencakup enam sasaran (Kemenkes, 2011), yaitu:

- a. Ketetapan identifikasi pasien;
- b. Peningkatan komunikasi yang efektif;
- c. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai;
- d. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien operasi;

- e. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan Kesehatan;
- f. Pengurangan risiko pasien jatuh;

B. Keselamatan Pasien dalam Asuhan Keperawatan

Asuhan keperawatan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai pelayanan kesehatan dalam Upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dengan menggunakan metodologi proses keperawatan yang terdiri dari lima tahap, berpedoman kepada standar keperawatan, dilandasi etik dan etika keperawatan, dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab perawat.

Asuhan keperawatan merupakan proses atau rangkaian kegiatan atau praktek keperawatan yang diberikan secara langsung kepada klien/pasien diberbagai tatanan pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, bersifat humanistik dan berdasarkan pada kebutuhan objektif klien untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Dengan asuhan keperawatan maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ilmiah yaitu: logis, sistimatis, dinamis, dan terstruktur. Jadi dapat artikan proses keperawatan adalah sebagai alat bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada pasien yang mana memiliki arti penting bagi kedua belah pihak yaitu perawat dan klien.

Sebagai seorang perawat, proses keperawatan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah klien dengan menunjukkan profesionalitas yang tinggi dan dapat memberikan

kebebasan pada klien untuk mendapatkan pelayanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan.

C. Tujuan Proses Keperawatan

Proses keperawatan adalah metode yang digunakan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara sistematis, terorganisir, dan ilmiah. Proses keperawatan bertujuan untuk membantu pasien mencapai kesehatan yang lebih baik. Perkembangan pelayanan keperawatan saat ini telah melahirkan paradigma keperawatan yang menuntut adanya pelayanan keperawatan yang bermutu. Fungsi asuhan keperawatan (Perry and Potter, 2009), sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis dan ilmiah bagi tenaga keperawatan dalam memecahkan masalah klien melalui asuhan keperawatan;
2. Memberi ciri profesionalisasi asuhan keperawatan melalui pendekatan pemecahan masalah dan pendekatan komunikasi efektif dan efisien;
3. Memberi kebebasan pada klien untuk mendapat pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dalam kemandiriannya di bidang Kesehatan.

Tujuan lain proses keperawatan adalah:

1. Menggunakan standar untuk melaksanakan praktik keperawatan.
2. Memperoleh metode yang baku, sesuai, rational dan sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien.
3. Memperoleh metode yang bisa digunakan dalam segala situasi.
4. Memperoleh hasil asuhan keperawatan dengan kualitas yang tinggi.

Tahapan-tahapan dalam proses keperawatan adalah:

1. **Pengkajian:** Tahap pertama yang dilakukan perawat. Pengkajian keperawatan meliputi pengumpulan data, klasifikasi data, validasi data, dan perumusan masalah.
2. **Diagnosis:** Penilaian klinis mengenai respon pasien individu maupun komunitas terhadap masalah kesehatan.
3. **Perencanaan:** Menyusun rencana keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien. Perencanaan atau intervensi suatu langkah dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang terkait dengan keputusan awal tentang sesuatu apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukan.
4. **Implementasi:** Mengolah rencana keperawatan yang telah disusun.
5. **Evaluasi:** Menentukan apakah rencana keperawatan efektif, dan merevisi atau menghentikan rencana jika perlu. Evaluasi keperawatan juga merupakan kegiatan yang terus dilakukan untuk menentukan apakah rencanan keperawtaan tersebut efektif dan juga bagaimana rencana keperawatan tersebut dilakukan, serta merevisi rencana atau bahkan menghentikan rencana.

Proses keperawatan dirancang untuk digunakan sepanjang rentang hidup pasien, dan dapat membantu pasien dalam situasi apa pun.

D. Penerapan Standar Asuhan Keperawatan Terhadap Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit

Keselamatan adalah suatu system yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi assesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya. Keselamatan menjadi isu global dan terangkum dalam lima isu penting yang terkait di rumah sakit yaitu keselamatan pasien, keselamatan pekerja atau petugas kesehatan, keselamatan bangunan dan peralatan di rumah sakit, keselamatan lingkungan dan keselamatan bisnis rumah sakit yang terkait dengan kelangsungan hidup rumah sakit. Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera maka diperlukan standar keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan acuan untuk melaksanakan kegiatannya.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 43 menjelaskan bahwa rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan melalui pelaporan, insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah. Pelaporan insiden keselamatan pasien dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dalam membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi pengkajian risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan

risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden (Permenkes RI No 1691, 2011).

Setiap manajemen rumah sakit diwajibkan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit khususnya keselamatan pasien rawat inap yang baik. Hal ini didukung oleh adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1691/MENKES/PER/VII/2011 tentang keselamatan pasien di rumah sakit yang membahas mengenai sasaran keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2011; Sinaga et al, 2019).

Salah satu standar keselamatan pasien yang telah ditetapkan oleh JCI (Joint Commission International) adalah sasaran pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit atau disebut dengan National Patient Safety Goals for Hospital meliputi identifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi efektif, menggunakan obat secara aman, kepastian tepat lokasi, prosedur dan tepat pasien, menurunkan risiko infeksi, dan mengidentifikasi risiko jatuh pasien (Chalik et al, 2019). Ada lima isu penting yang terkait dengan keselamatan di rumah sakit yaitu:

1. Keselamatan pasien (patient safety);
2. Keselamatan pekerja atau petugas Kesehatan;
3. Keselamatan bangunan dan peralatan di rumah sakit;
4. Keselamatan lingkungan (green productivity);
5. Keselamatan bisnis rumah sakit.

Ke lima aspek keselamatan tersebut sangatlah penting untuk dilaksanakan di setiap rumah sakit. Harus diakui kegiatan institusi rumah sakit dapat berjalan apabila ada pasien. Karena itu keselamatan pasien merupakan prioritas utama untuk dilaksanakan dan hal tersebut terkait dengan isu mutu dan citra perumahsakit (Ningsih, 2020).

Keselamatan pasien berperan penting dalam asuhan keperawatan yang berkualitas. Hal ini menjadi penting karena keselamatan pasien adalah suatu langkah untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam memberikan asuhan keperawatan. Inti dari keselamatan pasien yaitu penghindaran, pencegahan dan perbaikan dari kejadian yang tidak diharapkan serta mengatasi cedera-cedera dari 4 proses pelayanan kesehatan. Prosedur keselamatan pasien ini sangat menjamin peningkatan mutu dari rumah sakit. Karena suatu rumah sakit dapat dikatakan baik jika pelayanan untuk keselamatan pasien juga sudah baik.

Keselamatan pasien merupakan sistem yang dibentuk rumah sakit untuk mencegah dan mengurangi kesalahan dalam perawatan terhadap pasien akibat dari kelalaian atau kesalahan asuhan yang diberikan (Hutafea et al, 2021). Keselamatan pasien rumah sakit merupakan sistem yang dibuat untuk mencegah terjadinya KTD yang disebabkan ada tidaknya tindakan oleh medis atau nonmedis (Hutauruk, 2021).

Suatu jaminan segala tindakan dan aktivitas yang berhubungan dengan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan agar berlangsung dengan aman. Memberikan citra yang besar, tanggung jawab sosial moral serta kinerja petugas kesehatan agar mutunya menjadi lebih baik. Keselamatan pasien akan terus berkembang, yang didefinisikan sebagai upaya maksimal yang dilakukan rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kepada pasien melalui penerapan metode dan regulasi yang legal serta melalui standar yang terukur untuk meminimalisir kesalahan medis.

Menurut Chalik et al (2019), perilaku perawat dalam melaksanakan keselamatan pasien dipengaruhi oleh

berbagai macam faktor yang berkontribusi terhadap insiden keselamatan pasien. Kesalahan praktek keperawatan dapat terjadi dalam tahap pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, pelaksanaan perencanaan keperawatan, evaluasi atau penilaian proses keperawatan.

Proses keperawatan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengenai masalah-masalah pasien dan mencari alternatif pemecahan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasien, memperbaiki, dan meningkatkan kesehatan pasien sampai tahap maksimum, dan terdiri dari tahap yaitu: pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Komponen standar asuhan keperawatan (Depkes, 1995) terdiri dari:

1. Standar pengkajian keperawatan, meliputi pengumpulan data dengan kriteria menggunakan format yang baku, sistematis, di sesuai item yang tersedia, aktual, data terbaru, absah dan valid. Pengelompokan data dengan dengan kriteria data biologis, data psikologis, data sosial dan data spritual, perumusan masalah dengan kriteria kesenjangan antara status kesehatan dengan norma dan pola fungsi kehidupan dan perumusan masalah ditunjang oleh data yang telah dikumpulkan.
2. Standar diagnosa keperawatan, dirumuskan berdasarkan data status kesehatan pasien, dianalisis dan dibandingkan dengan norma fungsi kehidupan pasien dengan kriteria: diagnosis dihubungkan dengan penyebab kesenjangan dan pemenuhan kebutuhan pasien, dibuat sesuai dengan wewenang perawat, komponennya terdiri dari masalah, penyebab dan gejala, bersifat aktual atau potensial, dan dapat ditanggulangi oleh perawat.

3. Standar perencanaan keperawatan, melalui prioritas masalah, tujuan asuhan keperawatan dan rencana tindakan dengan kriteria: disusun berdasarkan tujuan asuhan keperawatan, melibatkan, pasien dan keluarga, mempertimbangkan latar belakang budaya, menentukan alternative tindakan yang tepat, mempertimbangkan kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku, lingkungan, sumber daya dan fasilitas yang ada, menjamin rasa aman dan nyaman bagi pasien, serta memakai kalimat instruksi, ringkas, tegas dengan bahasa yang mudah dimengerti.
4. Standar tindakan keperawatan dengan kriteria : dilaksanakan sesuai dengan rencana keperawatan, menyangkut keadaan pasien, menjelaskan setiap tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, menggunakan sumber daya yang ada, menerapkan prinsip aseptik dan antiseptik, menerapkan prinsip aman. Nyaman, ekonomik, privacy dan mengutamakan Kesehatan pasien, melaksanakan perbaikan tindakan berdasarkan respon pasien, merujuk dengan segera bila ada masalah yang mengancam keselamatan pasien, mencatat semua tindakan yang telah dilaksanakan, merapikan pasien dan alat setiap selesai melakukan tindakan, dan melaksanakan tindakan keperawatan berpedoma pada prosedur teknis yang telah ditentukan.
5. Standar evaluasi keperawatan, dilakukan secara priodik, sistematis dan berencana untuk menilai perkembangan pasien dengan kriteria: setiap tindakan perawat dilakukan evaluasi, evaluasi hasil menggunakan indikator yang ada pada rumusan tujuan, hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan, evaluasi melibatkan pasien, keluarga

dan tim kesehatan lain, dan dilakukan sesuai dengan standar;

6. Standar dokumentasi/catatan asuhan keperawatan, dengan kriteria dilakukan selama pasien di rawat inap dan rawat jalan, sebagai bahan informasi, komunikasi dan laporan, dilakukan segera setelah tindakan dilaksanakan, penulisannya harus jelas, ringkas serta menggunakan istilah yang baku, sesuai dengan pelaksanaan proses keperawatan, mencantumkan initial/paraf/nama perawat dan waktu pelaksanaan, menggunakan formolir.

Tahap pengkajian keperawatan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perawat dalam menggali permasalahan dari klien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Pengkajian keperawatan secara umum terdiri atas anamnesis dan pemeriksaan fisik. Keahlian dalam melakukan observasi, komunikasi, wawancara dan pemeriksaan fisik sangat penting untuk mewujudkan fase pengkajian keperawatan yang akurat.

Tujuan dari diagnosis keperawatan adalah memungkinkan perawat untuk menganalisis dan mensintesis data yang telah dikelompokkan dibawah pola kesehatan. Langkah-langkah menentukan diagnosis keperawatan (Hidayat, 2011), yaitu:

1. Klasifikasi data
Klasifikasi data adalah aktivitas mengelompokkan data-data klien atau keadaan tertentu tempat klien mengalami permasalahan kesehatan atau keperawatan berdasarkan kriteria permasalahan.
2. Interpretasi data Perawat bertugas membuat interpretasi data yang sudah di kelompokkan dalam bentuk masalah keperawatan atau masalah kolaboratif.
3. Menentukan hubungan sebab akibat

Dari masalah keperawatan yang telah ditentukan kemudian, perawat menentukan faktor-faktor yang berhubungan atau factor risiko yang menjadi kemungkinan penyebab dari masalah yang terjadi.

4. Merumuskan diagnosis keperawatan, perumusan diagnosis didasarkan pada identifikasi masalah dan kemungkinan penyebab.

Keselamatan pasien di rumah sakit sangat erat hubungannya dengan profesionalisme tenaga medis yang terkait, seperti dokter, perawat, bidan, *radiologist*, dsb. Profesionalisme di sini dapat ditunjukkan dengan 3 hal yang penting yaitu *knowledge*, *skill*, dan *attitude* para tenaga medis tersebut. Perawat yang mengemban beban kerja terlalu tinggi dilaporkan lebih sering melakukan kesalahan dan mengalami kejadian pasien jatuh pada saat mereka berdinasi. (Sochalski (2004). Ada kemungkinan beban kerja yang berat telah mengubah perilaku perawat dari yang sebelumnya berperilaku aman menjadi perilaku tidak aman. Hal tersebut dapat mempengaruhi keselamatan pasien. Sehingga perilaku tidak aman tadi dapat menyebabkan perawat tersebut melakukan kesalahan.

Perawat mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Patient safety di rumah sakit yaitu sebagai pemberi pelayanan keperawatan, perawat harus mematuhi semua standar pelayanan dan SOP yang telah dibuat dan ditetapkan oleh rumah sakit serta tidak luput pula dalam menerapkan prinsip-prinsip etik dalam pemberian pelayanan keperawatan, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang asuhan yang diberikan, menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian yang tidak diharapkan, melakukan pendokumentasian dengan

benar dari semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga serta komunikasi efektif yang merupakan hal yang sangat berperan terhadap keberhasilan suatu pelayanan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya.

Peran perawat dalam memberikan keselamatan pasien di rumah sakit (patient safety) dapat dilakukan dengan cara berikut :

Perawat dapat melakukan hal yang berkaitan dalam 7 Standar Keselamatan Pasien (mengacu pada "*Hospital Patient Safety Standards*" yang dikeluarkan oleh *Joint Commision on Accreditation of Health Organizations, Illinois, USA*, tahun 2002) ,yaitu:

1. Perawat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya agar mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya KTD (Kejadian Tidak Diharapkan).
2. Perawat memberikan pengarahan, perencanaan pelayanan kesehatan pada pasien dan keluarga mengenai keselamatan pasien.
3. Menjaga keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan.
4. Menggunakan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien.
5. Menerapkan peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
6. Menerima pendidikan tentang keselamatan pasien
7. Menjaga komunikasi sebagai kunci bagi perawat untuk mencapai keselamatan pasien.

Dan setiap Setiap perawat mempunyai tanggung jawab melakukan : Assesment (Pengkajian) : Status kesehatan pasien saat ini dan masa lalu serta potensi resiko (keselamatan pasien). Diagnosa : menetapkan diagnosa/ masalah keperawatan. Planning : Rencana asuhan keperawatan. Implementation : Pelaksanaan asuhan sesuai rencana Evaluation : evaluasi terhadap respon pasien dan outcome.

Pelaksanaan *Patient Safety* tersebut salah satu pendukungnya adalah peran perawat di setiap ruangan. Peran perawat sebagian masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan sifat dan pemahaman masing-masing individu berbeda-beda. Terdapat beberapa perawat yang motivasi kurang dan pemahaman yang kurang baik terkait dengan beberapa standar pelayanan keperawatan yang harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammouri AA, Tailakh AK, Muliira JK, Geethakrishnan R, Al Kindi SN. Patient safety culture among nurses. *Int Nurs Rev.* 2015;62(1):102–10. 2015 Mar;62(1):102-10.doi: 10.1111/inr.12159. Epub 2014 Dec 11.
- Assiri GA, Shebl NA, Mahmoud MA, Aloudah N, Grant E, Aljadhey H, et al. What is the epidemiology of medication errors , error-related adverse events and risk factors for errors in adults managed in community care contexts ? A systematic review of the international literature. 2018; May 5;8(5):e019101.doi: 10.1136/bmjopen-2017-019101.
- Boamah SA, Laschinger HKS, Wong C, Clarke S. Effect of transformational leadership on job satisfaction and patient safety outcomes. *Nurs Outlook.* 2018;66(2):180–9. Mar-Apr 2018;66(2):180-189.doi: 10.1016/j.outlook.2017.10.004. Epub 2017 Nov 23.
- Gaffney TA, Hatcher BJ, Milligan R. Nurses ' role in medical error recovery : an integrative review. 2016 Apr;25(7-8):906-17.doi: 10.1111/jocn.13126. Epub 2016 Feb 11.
- Gottlieb LN, Gottlieb B, Bitzas V. Creating empowering conditions for nurses with workplace autonomy and agency: How healthcare leaders could be guided by strengths-based nursing and healthcare leadership (SBNH-L). *J Healthc Leadersh.* 2021 Jul 27;13:169-181.doi: 10.2147/ JHL.S221141.
- Heo JI, Moon H. Moderating effect of empowerment of perioperative nurses in the relationship between

their patient safety culture awareness and safety management activities. *Nurs Heal Issues*. 2019;24(2):89–95.

Lee C-H, Lee C-Y, Hsu M-Y, Lai C-L, Sung Y-H, Lin C-Y, et al. Effects of Music Intervention on State Anxiety and Physiological Indices in Patients Undergoing Mechanical Ventilation in the Intensive Care Unit. *Biol Res Nurs*. 2017 Mar;19(2):137–44. 2017 Mar;19(2):137-144.doi: 10.1177/1099800416669601. Epub 2016 Sep 21.

Lee Y-J. Patient safety culture and management activities perceived by hospital nurses. Unpubl master's thesis, Eulji Univ Daejeon. 2011;

Lee GO. The study on nurse manager leadership and patient safety-related nursing activities. Unpubl master's thesis, Kyung Hee Univ Seoul. 2009;

Malone G, Darcy C. Perceptions of 'just culture'- the case of aircraft maintenance. *J Strateg Innov Sustain*. 2019;14(1):48–65. DOI: <https://doi.org/10.33423/jsis.v14i1.986>

Metwally FG. Relationship between Structural Empowerment, Magnet Hospital Characteristics and Patient Safety Climate among Nurses Working in Intensive Care Units. *Zagazig Nurs J*. 2015;11(2):219–32. DOI: 10.12816/0029201.

Olsen RM, Bjerkan J. Patient safety culture in Norwegian home health nursing : a cross- sectional study of healthcare provider ' s perceptions of the teamwork and safety climates. 2017;1–8.

Padgett J, Gossett K, Mayer R, Chien W-W, Turner F. Improving

Patient Safety through High 281Mal J Med Health Sci 18(SUPP17): 280-285, Dec 2022 Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences (eISSN 2636-9346) Reliability Organizations. Qual Rep. 2017;22(2).

Petschonek S. Developing the Just Culture Assessment Tool: A method for measuring individual cultural perceptions in a healthcare setting. The University of Memphis; 2011. 2013 Dec;9(4):190-7.doi: 10.1097/ PTS.0b013e31828fff34.

Richardson A, Storr J. Patient safety: a literative review on the impact of nursing empowerment, leadership and collaboration. Int Nurs Rev. 2010;57(1):12–21. 2010 Mar;57(1):12-21.doi:10.1111/j.1466-7657.2009.00757.x.

Schwendimann R, Blatter C, Dhaini S, Simon M, Ausserhofer D. The occurrence , types , consequences and preventability of in-hospital adverse events – a scoping review. 2018;1–13. 2018 Jul 4;18(1):521.doi: 10.1186/s12913-018-3335-z.

Tawfik DS, Thomas EJ, Vogus TJ, Liu JB, Sharek PJ, Nisbet CC, et al. Safety climate , safety climate strength , and length of stay in the NICU. 2019;1:1–11. 2019 Oct 22;19(1):738.doi: 10.1186/s12913-019-4592-1.

Walker D, Altmiller G, Barkell N, Hromadik L, Toothaker R. Development and validation of the Just Culture Assessment Tool for nursing education. Nurse Educ. 2019;44(5):261–4. Sep/Oct 2019;44(5):261-264.doi: 10.1097/ NNE.0000000000000705.

Westat R, Sorra J, Famolaro T, Dyer MPSN, Khanna K, Nelson D.

Hospital survey on patient safety culture: 2010 User
Comparative Database Report. Agency Healthc Res
Qual US Dep Heal Hum Serv. 2010;

WHO. Patient Safety Fact File. 2019.

GLOSARIUM

A

Advocat : adalah : Orang yang berprofesi dibidang huikum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat dan berdasarkan ketentuan UU /pembela

Adverse Event.: Adalah Incident Yang Mengakibatkan cidera

C

Coordinator: Adalah orang yang mengelola/ mengkoordinasikan aktifitas pada wilayah tertentu

Colaboratif: Adalah suatu bentuk Kerjasama dengan pihak lain untuk menuju visi/ tujuan bersama

G

Green Product : Adalah Product Yang aman

I

Incervice Training : Suatu Usaha pelatihan atau pembinaan yang memberi kesempatan kepada seseorang yang mendapat tugas jabatan tertentu untuk mendapat pengembangan kinerja

Incident : Kejadian dari sesuatu yang terjadi atau kejadian tak terduga yang tidak mengakibatkan cidera

J

JCI : Joint Comission International (system operasional yang penting bagi keselamatan dan kualitas perawatan pasien)

K

KKPRS adalah Komite Keselamatan pasien rumah sakit

KNC adalah : Kejadian nyaris cidera

KTD adalah Kejadian tidak diharapkan

R

RCA adalah **Root Cause Analysis** yaitu analisis akar masalah

S

Sporty Culture adalah Nilai, sikap dan perilaku yang terkait dengan praktek olahraga

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Ernawati Umar, S.Kep., M.Kes., DNM.

Lahir di Metro, 08 Nopember 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia dan lulus tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan kuliah S3 pada Trinity University Of Asia di Filipina, Lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1992 bekerja di SPK Metro sebagai Guru SPK, pada tahun 1993 pindah ke Kantor Departemen Kesehatan di Kota Serang sampai tahun 2000. Pada tahun 2000 penulis pindah bekerja di Akper Kabupaten Serang, kemudian merger ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2017 Saat ini penulis bekerja di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Komunikasi Terapeutik, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Pengabdian Masyarakat, Serta Prosedding. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ernawati.umar@untirta.ac.id / ernawatiumar08@gmail.com

Motto: **"Bersyukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang bermakna."**

DAFTAR ISI



Ns. Tuti Sulastrri, Skep., M.Kep., lahir di Lampung, Bahuga 14 Agustus 1971, Penulis menghabiskan waktu sekolah SDN sampai SMAN di Lampung dan melanjutkan ke AKPER DepKes Tanjung Karang. Tahun 1993 Bekerja di RSBW, kemudian pada tahun 1994 bekerja di RS.Abdul Moeluk diruang Syaraf dan bedah Syaraf menjadi CI, sambil membimbing dan mengajar di Akper Panca Bhakti sampai tahun 1997. Lulus S1 Keperawatan dan Melanjutkan S2 Magister keperawatan Medikal Bedah di Universitas Indonesia. Penulis pada tahun 2007 bergabung dengan AKPER PEMDA Kabupaten Serang sebagai Pengajar sampai Tahun 2017. Tahun 2018 sampai sekarang menjadi dosen di Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di Prodi Keperawatan Penulis Mengajar Keperawatan Medikal Bedah, Farmakologi Keperawatan, IPE (Komunikasi Kolaborasi Kesehatan) Kebutuhan Dasar Manusia dan Konsep Dasar Keperawatan, Buku yang pernah Penulis terbitkan antara lain, Farmakologi Keperawatan, Modul Praktik Keperawaytan Medikal bedah I, II dan III. Modul Praktik Kebutuhan Dasar Manusia. Motto Rahasia kebahagiaan itu ada dalam tiga hal: bersabar, bersyukur, dan ikhlas.

SINOPSIS BUKU

Budaya keselamatan memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang aman bagi pasien. Masih ditemui masalah terkait budaya keselamatan pasien dan sikap pelaporan insiden keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien dapat berhubungan dengan sikap perawat dalam pelaporan insiden. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan budaya keselamatan pasien dengan sikap perawat dalam pelaporan insiden keselamatan pasien.

Penerapan budaya keselamatan pasien yang memadai akan menghasilkan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya dinilai dari kelengkapan teknologi, kecanggihan infrastruktur, dan tenaga kesehatan yang profesional, tetapi juga dari proses dan hasil pelayanan yang diberikan (Siregar, 2020)

Mengacu kepada standar keselamatan pasien, maka rumah sakit harus merancang proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien

Tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit merupakan panduan yang komprehensif untuk menuju keselamatan pasien, sehingga tujuh langkah tersebut secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit.

Budaya keselamatan memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang aman bagi pasien. Masih ditemui masalah terkait budaya keselamatan pasien dan sikap pelaporan insiden keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien dapat berhubungan dengan sikap perawat dalam pelaporan insiden. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan budaya keselamatan pasien dengan sikap perawat dalam pelaporan insiden keselamatan pasien.

Penerapan budaya keselamatan pasien yang memadai akan menghasilkan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya dinilai dari kelengkapan teknologi, kecanggihan infrastruktur, dan tenaga kesehatan yang profesional, tetapi juga dari proses dan hasil pelayanan yang diberikan (Siregar, 2020)

Mengacu kepada standar keselamatan pasien, maka rumah sakit harus merancang proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit merupakan panduan yang komprehensif untuk menuju keselamatan pasien, sehingga tujuh langkah tersebut secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-16-0



9

786347

139160

